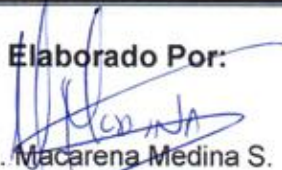
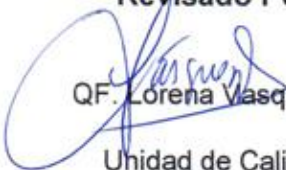
	CENTRO DE SALUD FAMILIAR VILLA NONGUÉN GCL 3.2	
---	--	---

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN EN SALUD (IAAS)

Elaborado Por:  EU. Macarena Medina S. Encargado de IAAS NOVIEMBRE 2024	Revisado Por:  QF. Lorena Vasquez V. Unidad de Calidad DICIEMBRE 2024	Aprobado Por:  Sociólogo Leonel Zúñiga F. Director DICIEMBRE 2024
--	--	---



Centro de Salud Familiar Villa Nonguén

Código: GCL 3.2

Edición: 04

Fecha Elab: Diciembre 2024

Página 2 de 51

Vigencia: Diciembre 2029

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREVENCIÓN Y CONTROL IAAS

INDICE

TEMAS	PAGINAS
Precauciones Estándar	3-21
Precauciones Adicionales	22 - 27
Técnica Aséptica	28 - 36
Antisépticos y desinfectantes	37 - 42
Medidas de Prevención IAAS	43 - 49
Bibliografía	50



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREVENCIÓN Y CONTROL IAAS

1. PRECAUCIONES ESTÁNDAR

INTRODUCCIÓN

Las infecciones asociadas a la atención en salud son un problema de importancia vital en el país y el mundo entero. Se asocian en la gran mayoría de los casos a transgresión a las normas o buenas prácticas en atención de salud; por lo tanto, son prevenibles.

Se basan en el principio de que la sangre, todos los fluidos corporales, secreciones, excreciones, piel no intacta y membranas mucosas (exceptuando sudor y lágrimas e incluyendo saliva en el ámbito dental), pueden contener agentes infecciosos que pueden transmitirse por contacto directo o indirecto.

Es así que el personal que brinda atención de pacientes está en riesgo de adquirir microorganismos patógenos a consecuencia de sus labores, pero también de transmitir microorganismos patógenos a los pacientes y de servir como vehículo de transmisión entre pacientes.

Las acciones más básicas y de mayor impacto son el respeto a las precauciones estándar y las precauciones adicionales.

OBJETIVO

- Evitar la transmisión de agentes patógenos por contacto con fluidos biológicos del personal al paciente y del paciente al personal mediante conductas seguras y uso de barreras apropiadas.

RESPONSABLES

RESPONSABLE	ACTIVIDAD
Funcionarios con atención clínica directa	• Cumplir la norma
Encargados de áreas Dental, Procedimientos, Matrona, IRA- ERA, Vacunatorio, Podología	• Hacer cumplir la norma.
Enfermera de IAAS	• Revisar la normativa MINSAL e incorporarlas a protocolos locales. • Supervisar el cumplimiento de las normas y protocolos.



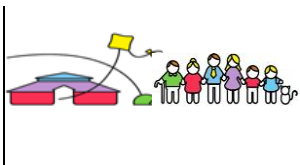
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREVENCIÓN Y CONTROL IAAS

DEFINICIONES

- **Precauciones Estándar:** Es el conjunto de procedimientos destinados a minimizar el riesgo de adquirir enfermedades por el personal de la salud al exponerse a productos biológicos potencialmente contaminados en la práctica clínica. Las precauciones estándar deben aplicarse en la práctica de la atención de cualquier paciente en todo momento y en cualquier ámbito de la atención de salud.

Sus componentes son:

1. Higiene de manos
 2. Uso de equipo de protección personal (EPP)
 3. Prevención de pinchazos y cortes con artículos afilados
 4. Higiene respiratoria "Etiqueta de la tos", buenos hábitos al toser/estornudar
 5. Manejo de equipos, desechos y ropa de pacientes
 6. Limpieza y desinfección
- **Infección:** Presencia y multiplicación de Microorganismos en sitios corporales, con respuesta clínica (síntomas y signos de enfermedad) e inmunológica.
 - **Secreciones o Sustancias Corporales:** Se considera a todos los fluidos corporales (sangre, heces, orina, expectoración, saliva, secreciones y pus entre otros) de todos los pacientes como potencialmente infectantes.
 - **Fluido corporal:** Cualquier secreción o líquido biológico que se produce en el organismo. Se clasifican en:
 - **Fluido corporal de alto riesgo:** Sangre, secreciones genitales (semen, secreción vaginal), fluidos corporales provenientes de cavidades normalmente estériles y cualquier otro fluido con "sangre visible".
 - **Fluido corporal de bajo riesgo:** Saliva, sudor, deposiciones y orina. No se han descrito en el mundo casos de transmisión del VIH por exposición a estos fluidos.
 - **Equipo de Protección Personal (EPP):** Es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo. (Anexo 1)



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREVENCIÓN Y CONTROL IAAS

1.1 NORMA DE HIGIENE DE MANOS

Introducción

La higiene de manos es la medida primordial para reducir las IAAS, aunque se trata de una práctica sencilla, su incumplimiento entre los prestadores de la atención en Salud es frecuente. El reto mundial por la Seguridad del paciente, “una atención limpia es una atención más segura” parte de su atención está centrado en mejorar las prácticas del lavado de manos ya que está comprobado que esta sencilla técnica disminuye significativamente el riesgo de efectos adversos en los usuarios y personal clínico.

Cabe destacar que la higiene de manos de uso clínico debe realizarse siempre previo a todo procedimiento que requiera la aplicación de técnica aséptica.

Objetivos:

- Prevenir diseminación de microorganismos por vía mano portada.
- Eliminar la flora microbiana transitoria y disminuir la flora microbiana normal de la piel (lavado clínico).

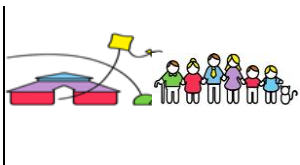
Indicaciones: “Los 5 momentos” u oportunidad:

Los 5 momentos u oportunidad (Anexo 2) de indicación de higiene de manos señalan los puntos críticos de mayor riesgo de transmisión de infecciones representan, por ende, los momentos idóneos para esta práctica al romper la cadena de transmisión de los agentes infecciosos.

1. Previo a realizar una técnica aséptica.
2. Previo contacto con un paciente.
3. Después del contacto con fluidos corporales.
4. Después del contacto con el paciente.
5. Después del contacto con el entorno del paciente.

Consideraciones generales para la higiene de manos con agua y jabón:

- El tiempo de duración es de 40 - 60 segundos.
- Uñas cortas, limpias y sin esmalte, queda prohibido el uso de uñas postizas.
- Uso de guantes no reemplaza el lavado de manos
- Manos partidas y/o agrietadas favorecen la colonización de la flora bacteriana transitoria, en cuyo caso el lavado de manos no cumple con su objetivo, es preferible usar guantes de procedimientos.



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREVENCIÓN Y CONTROL IAAS

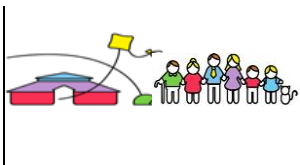
- Para evitar las grietas retirar bien los residuos de jabón, utilizar agua tibia o fría, el agua caliente retira barrera protectora de la piel.
- Utilizar para higiene de manos la salida de jabón del dispensador en una sola vez, evitar grandes porciones de jabón.

Procedimiento higiene de manos con agua y jabón: (Anexo 3)

1. Manos y antebrazos libres de joyas y accesorios.
2. Moja las manos y aplique jabón.
3. Friccióna manos y muñecas, incluyendo zonas interdigitales y uñas
 - Frota las palmas de las manos entre sí.
 - Frota la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos, y viceversa.
 - Frota las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados.
 - Frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose de los dedos.
 - Frota con movimiento de rotación, el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma de la mano derecha, y viceversa.
 - Frota la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación, viceversa.
4. Enjuague las manos dejando escurrir el agua.
5. Seca las manos con toalla desechable.
6. Cierra la llave del agua con la toalla desechable sin contaminarse.

Consideraciones generales para la higiene de manos con alcohol gel:

- Utilizar alcohol gel solo **en manos limpias, sin suciedad o materia orgánica visible**
- El tiempo de duración es de 20-30 segundos, hasta que se seque el alcohol gel.
- No enjuague sus manos después de aplicar alcohol gel, este tipo de soluciones debe secarse las manos, para lograr el efecto deseado.
- Lávese las manos con agua corriente y jabón antiséptico cada vez que éstas se contaminen con sangre y secreciones.
- El alcohol gel se puede utilizar 4 veces y posteriormente a esto se recomienda lavado de manos.



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREVENCIÓN Y CONTROL IAAS

Procedimiento higiene de manos con alcohol gel:

1. Deposite en la palma de la mano una dosis de antiséptico alcohol gel.
2. Friccióna manos y muñecas, incluyendo zonas interdigitales y uñas
 - Frota las palmas de las manos entre sí.
 - Frota la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos, y viceversa.
 - Frota las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados
 - Frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose de los dedos.
 - Frota con movimiento de rotación, el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma de la mano derecha, y viceversa.
 - Frota la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación, viceversa
3. Deje secar sus manos.

1. 2 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

1.2.1 GUANTES

Objetivo:

- Generar protección como barrera física de los microorganismos infecciosos que se encuentran en la sangre, líquidos corporales y material contaminado.

Indicaciones:

- Al tener contacto con sangre, fluidos orgánicos, excreciones, mucosas, piel lesionada.
- Al manipular material contaminado.
- Atención de pacientes que requieren precauciones especiales por la facilidad de transmisión del agente infeccioso a través de las manos.
- Al realizar cualquier procedimientos clínicos o exámenes que puedan presentar algún riesgo de infección al usuario/a.

Consideraciones:

- Los guantes sirven de barrera física que protege tanto a los profesionales de salud como a los usuarios.



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREVENCIÓN Y CONTROL IAAS

- Impiden que los profesionales tengan contacto con los microorganismos infecciosos que se encuentran en la sangre, en otros líquidos corporales y el material contaminado.
- A los usuarios también se les protege de posibles infecciones; los microorganismos normales que suelen habitar la piel de los profesionales de salud no se pueden transmitir a los usuarios cuando aquellos utilizan los guantes durante los exámenes físicos y procedimientos clínicos.
- El uso de guantes no reemplaza el lavado de manos. **Antes de ser colocados se debe realizar higienización de manos.**
- Los guantes deben cambiarse entre cada paciente y una vez terminado el procedimiento.
- Cambie los guantes durante la atención de un mismo paciente: si después de haber efectuado procedimientos en un sitio contaminado del cuerpo cambia a un sitio del cuerpo que está limpio.
- En el establecimiento existen 3 tipos de guantes y que se utilizan:

TIPO DE GUANTES	USO
Estériles	• En procedimientos invasivos, cirugía menor, toma de cultivo.
Procedimientos	• Al manipular sangre y fluidos
Domésticos	• Lavado de material, aseo, manipulación ropa sucia, retiro de residuos.

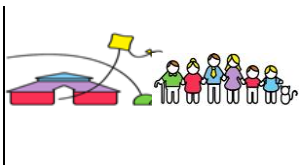
1.2.2 USO DE MASCARILLA

Objetivo

- Prevenir la transmisión de microorganismos infecciosos que se propagan a través del aire y aquellos cuyas puertas de entrada o salida pueden ser el aparato respiratorio.
- Establecer una barrera de aislamiento entre el paciente y la persona que lo atiende.

Indicaciones:

- Atención dental
- Atención podológica
- Kinesioterapia respiratoria



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREVENCIÓN Y CONTROL IAAS

- Campaña de invierno o área respiratoria
- Procedimientos invasivos (curaciones complejas, inserción y extracción DIU, extracción implante instalación de sondas, etc.).
- Aseo terminal

Consideraciones:

- A fin de no contaminar las manos, la mascarilla no debe tocarse ni colgar al cuello mientras se lleve puesta.
- Si el uso de la mascarilla está indicado, su colocación debe ser la primera maniobra que se realice para comenzar el procedimiento.
- Las mascarillas deben ser de un solo uso para ser una barrera efectiva.
- A fin de no contaminar las manos, la mascarilla NO debe tocarse, si es así realizar higienización de manos inmediatamente.
- Debe descartarse y cambiarse inmediatamente si está húmeda o manchada o dañada.
- Sólo se reutilizarán las mascarillas N95 o equivalente en caso de ser utilizada con protector ocular y de acuerdo con la clasificación de riesgo de paciente. (Paciente TBC o COVID activo eliminación inmediata)
- En nuestro establecimiento cuenta con 3 tipos de mascarillas cuya duración se encuentra estipulada en el siguiente cuadro:

TIPO DE MASCARILLA	DURACION
Simple o tres pliegues	2 horas
Copa simple	4 horas
N95 o KN95	3 días
Cambiar inmediatamente si esta húmeda, manchada o dañada independiente del tipo de mascarilla	

Procedimiento Colocación de Mascarilla (Anexo 4, 5)

- Lavarse las manos según norma.
- Colocarse la mascarilla cubriendo la nariz y la boca, luego amarrarla tomando solamente las tiras.
- Moldear a la altura de la nariz para que quede cómoda y segura.
- En caso de N95 o similar, realizar prueba de sellado
- Realice higienización de manos.



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREVENCIÓN Y CONTROL IAAS

Retiro De Mascarilla (Anexo 4)

- Desamarrar las tiras.
- Eliminar la mascarilla en depósito de desechos, sosteniéndola siempre de las amarras o banda elástica.
- Realice higienización de manos después de eliminarla.

1.2.3 USO DE PROTECTOR FACIAL Y/O OCULAR

Objetivo:

- Establecer una barrera protectora de fluidos corporales entre el paciente y la persona que lo atiende.

Indicaciones:

- Atención dental (dentista y paciente)
- Kinesioterapia respiratoria
- Aseo terminal
- Atención podológica
- Procedimientos con irrigación

Consideraciones:

- Se coloca primero la mascarilla y luego los lentes o protector facial, cuidando que queden bien sellados.
- El retiro se realiza en orden inverso.
- El protector indicado es aquel que no se empaña con la mascarilla
- Una vez utilizado debe ser limpiado y desinfectado para su reutilización.

1.2.4 USO DEL DELANTAL O PECHERA

Objetivo:

- Establecer una barrera mecánica entre la persona que lo usa y el paciente.

Indicaciones:

Pechera: Su uso está indicado en los procedimientos en que con frecuencia se producen derrames o salpicaduras de sangre u otro fluido corporal de riesgo, por ejemplo:

- Toma de muestra



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREVENCIÓN Y CONTROL IAAS

- Curaciones complejas con irrigación suero fisiológico
- Kinesioterapia respiratoria
- Instalación de sonda nasogástrica y catéter urinario
- Atención podológica
- Atención dental
- Aseo terminal

Consideraciones:

- El delantal y la pechera tiene dos caras: una estará siempre en contacto con el profesional (cara interna, considerada **Limpia**) y la otra con el paciente y ambiente (cara externa, considerada **Contaminada**).
- Los delantales deben estar físicamente indemnes para constituir una barrera eficaz, con las amarras, puños y costuras en buen estado, en el CESFAM sólo en el caso de cirugía menor de manera desechable.
- Si durante la atención del paciente el delantal se ensucia o moja debe ser cambiado tan pronto como sea posible.
- Los delantales una vez utilizados serán eliminados.

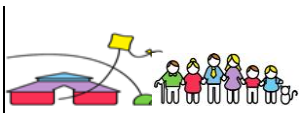
Procedimiento

Colocación:

- Lavar las manos según norma
- Tomar el delantal por el cuello
- Colocar sólo manipulando la cara interna.
- Amarrar cintas del cuello y luego la cintura, cubriendo totalmente el uniforme.

Retiro:

- Desamarrar cintas de la cintura y el cuello.
- Saque la primera manga, introduciendo el dedo de la otra mano, por debajo del puño (la cara interna se considera limpia).
- Saque la segunda manga, usando la primera para ayudar a deslizarla.
- Elimine el delantal.



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREVENCIÓN Y CONTROL IAAS

1.2.5 USO DE GORRO

Objetivo:

- Se usa con el fin de evitar en el personal de salud el contacto por salpicaduras por material contaminado y además evita la contaminación del paciente con los cabellos del trabajador de salud.
- El uso del gorro reduce la contaminación del campo quirúrgico por microbios desprendidos del pelo y cuero cabelludo.

Indicaciones:

- Cirugía menor
- Atención podológica
- Atención dental

Consideraciones

- Los gorros quirúrgicos son desechables, de un solo uso, y una vez utilizados deben ser depositados en el recipiente adecuado.

Procedimiento

- Tome el gorro y cubra completamente el cabello, incluido las patillas y la nuca.
- Evite que queden cabellos sueltos que puedan caer, o la caída de caspa sobre el uniforme, para una mayor protección y reducción de riesgos.
- Ajuste para mayor comodidad si contempla tirantes

1.3. PREVENCIÓN DE PINCHAZOS Y CORTES CON ARTÍCULOS AFILADOS

Objetivo:

- Prevenir la ocurrencia de pinchazos y cortes en el personal que manipula artículos afilados y material cortopunzante

Responsables:

- Equipo de salud o de unidades de apoyo que tiene contacto con artículos afilados y material cortopunzante.



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREVENCIÓN Y CONTROL IAAS

Aspectos normativos:

- El manejo de artículos cortopunzantes debe minimizar el riesgo de lesiones en particular si el artículo se encuentra contaminado con sangre o fluidos corporales.
- En ningún momento el filo o la punta del artículo debe apuntar hacia una parte del cuerpo (generalmente dedos o manos) del operador, ayudante u otra persona distinta al paciente. Especialmente durante el procedimiento mismo y al momento de trasladar el artículo hacia el sitio de desecho.
- Los artículos cortopunzantes deben eliminarse inmediatamente después de usarlos, en recipientes impermeables resistentes a las punciones (contenedor amarillo) que se encuentre próximo al sitio de uso para minimizar su traslado.
- Nunca se debe recapsular las agujas u otro material cortopunzante.

Eliminación de Material Cortopunzante:

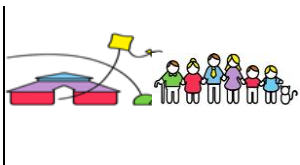
- La responsabilidad de eliminar el material cortopunzante es de quien lo utiliza.
- El material cortopunzante (agujas, hojas de bisturí) se deben desmontar con pinza tipo Kelly y se deben eliminar directamente en el contenedor amarillo con tapa sellada.
- Una vez completada 2/3 de la capacidad del contenedor amarillo, debe sellarse y ser retirado por auxiliar quien lo traslada al lugar de acopio de residuos.

1.4. “ETIQUETA DE LA TOS”, BUENOS HÁBITOS AL TOSER O ESTORNUDAR

Responsables: Todo el equipo de salud o de unidades de apoyo.

Aspectos normativos:

- Cubrir boca y nariz con un pañuelo desechable al toser o estornudar, desechar el pañuelo en un recipiente para desechos o basurero y posteriormente realizar higiene de las manos
- Como alternativa: toser/estornudar en antebrazo
- Higiene de manos después de cubrir la boca o nariz o manipulación de pañuelos (Anexo 6)



1.5. MANEJO DE EQUIPOS, DESECHOS Y ROPA

Aspectos normativos:

1. Manejo de ropa sucia desechable:

- El CESFAM utiliza ropa desechable y sabanillas de papel desechables.
- La ropa se debe manipular, transportar y procesar de modo tal que se logre prevenir exposiciones de la piel y mucosas con ropa contaminada y evitar el traspaso de agentes patógenos a otros pacientes y el ambiente.
- La ropa sucia desechable debe ser eliminada en los contenedores de eliminación de residuos. Las bolsas deben ser llenadas hasta $\frac{3}{4}$ de su capacidad para permitir su cierre.
- El personal que manipula la ropa sucia debe usar obligatoriamente elementos de protección personal.

2. Eliminación de desechos:

- Asegure la eliminación adecuada y segura de desechos según Norma REAS.
- Trate los desechos contaminados con sangre, fluidos orgánicos y secreciones como desechos especiales, en conformidad con los procedimientos locales.

1.6 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Aspectos normativos:

1. Manejo de equipos:

- Manipule el equipo manchado con sangre, fluidos orgánicos o secreciones, de forma tal que se prevengan exposiciones de la piel y mucosas, contaminación de la ropa.
- Limpie y desinfecte los equipos clínicos antes de la reutilización en otro paciente, utilizando limpieza por arrastre y alcohol de 70° o alcohol pad.
- Utilice jeringas y agujas estériles y de un solo uso en cada procedimiento y paciente.

2. Limpieza ambiental:

- Limpiar las superficies sucias o tocadas con frecuencia con los procedimientos y productos de rutina.
- Limpieza de instrumental con Alcohol de 70° o alcohol pad.
- Limpieza de superficies con amoníaco cuaternario, en caso de fluidos corporales de alto riesgo con cloro al 0.1%



Centro de Salud Familiar Villa Nonguén

Código: GCL 3.2

Edición: 04

Fecha Elab: Diciembre 2024

Página 15 de 51

Vigencia: Diciembre 2029

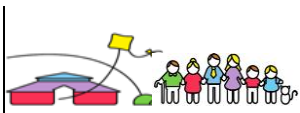
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREVENCIÓN Y CONTROL IAAS

INDICADOR:

- Seguimiento en carpeta del indicador

ANEXOS:

- Anexo 1: Cuadro resumen de equipo de Protección Personal por áreas
- Anexo 2: Momentos para la higiene de manos
- Anexo 3: Técnica de higiene de manos
- Anexo 4: Colocación y retiro de mascarilla tres pliegues
- Anexo 5: Colocación de mascarilla N95 o KN95
- Anexo 6: Etiqueta de la tos



ANEXO 1:

MOMENTOS PARA LA HIGIENE DE MANOS

Sus 5 Momentos para la Higiene de las Manos



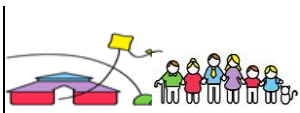


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREVENCIÓN Y CONTROL IAAS

ANEXO 2:

TECNICA DE HIGIENE DE MANOS



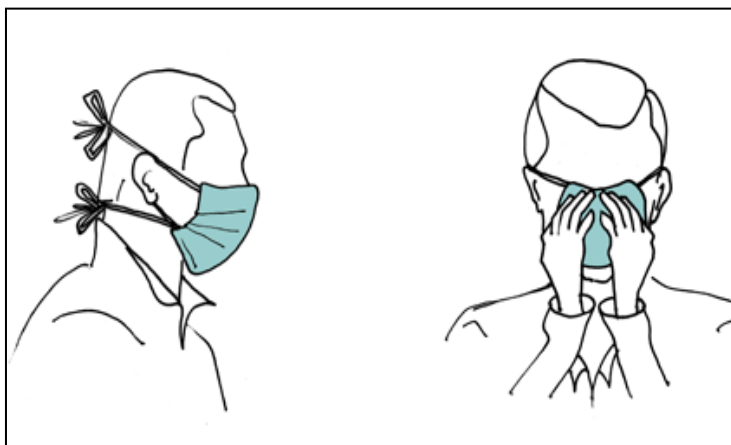


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREVENCIÓN Y CONTROL IAAS

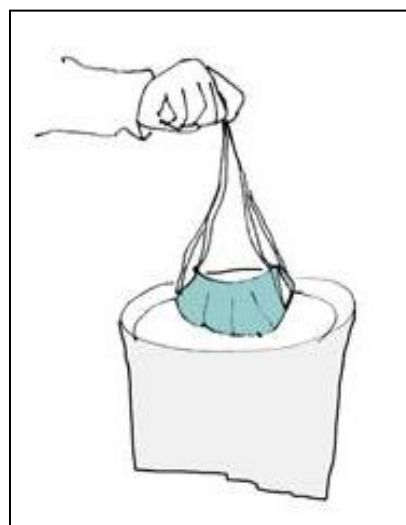
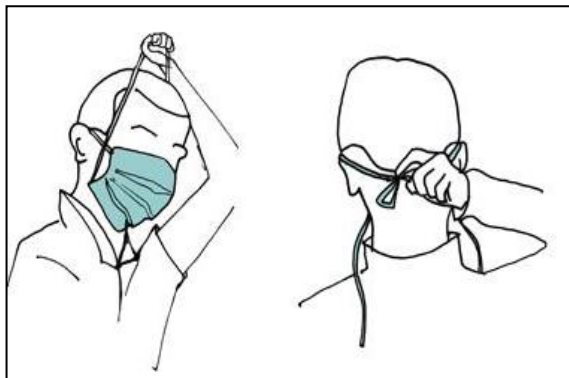
ANEXO 3:

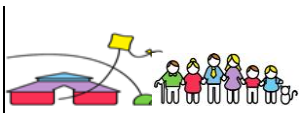
COLOCACION Y RETIRO DE MASCARILLA 3 PLIEGUES

1. Colocación de mascarilla



2. Retiro de mascarilla





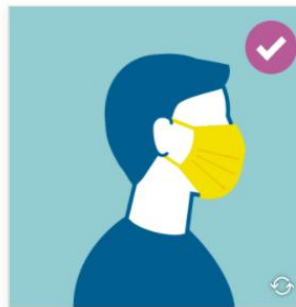
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREVENCIÓN Y CONTROL IAAS

ANEXO 4:

COLOCACIÓN DE MASCARILLA KN95 – N95



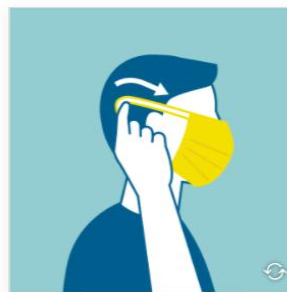
Lávese sus manos con agua y jabón o alcohol gel antes de colocarse la mascarilla.



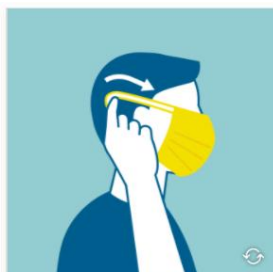
Lave o higienice sus manos cada vez que manipule la mascarilla.



Revise que la mascarilla no esté sucia, dañada o mojada.



Quite la mascarilla por los elásticos o tiras que se colocan tras las orejas o cabeza.



Asegúrese que cubra nariz, boca y mentón.



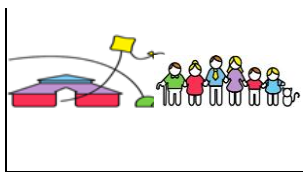
No quite la mascarilla por el frente ya que es el lugar más contaminado.



Evite tocar la mascarilla.

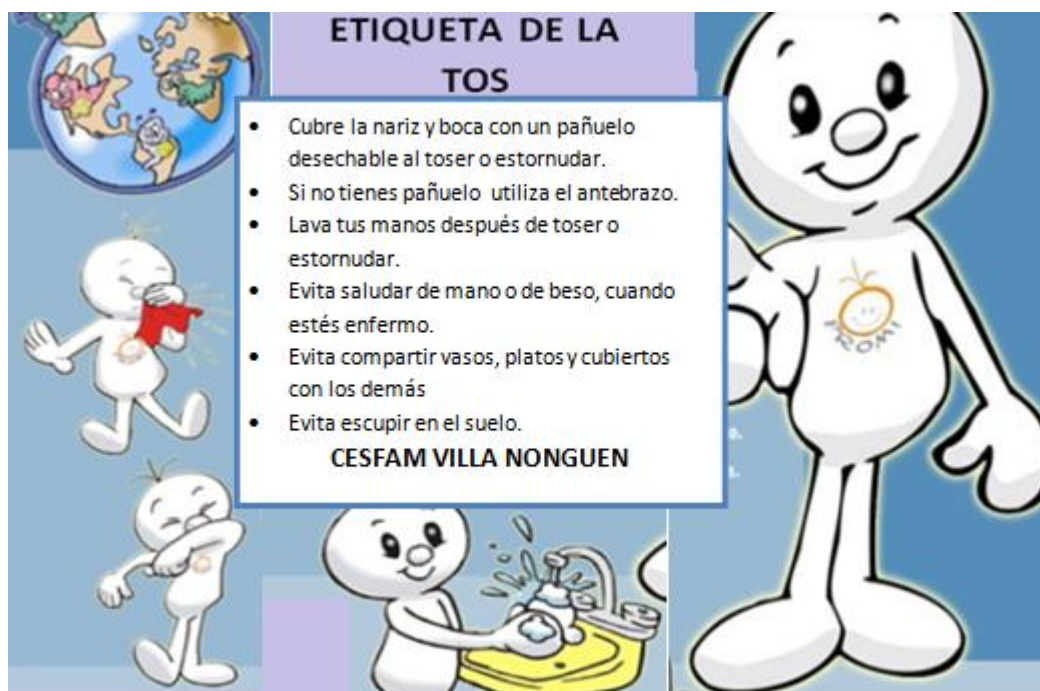


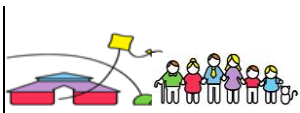
Lave sus **manos** con agua y jabón o alcohol gel después de quitarse la mascarilla.

	Centro de Salud Familiar Villa Nonguén	Código: GCL 3.2
		Edición: 04
		Fecha Elab: Diciembre 2024
		Página 20 de 51
		Vigencia: Diciembre 2029
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREVENCIÓN Y CONTROL IAAS		

ANEXO 5:

ETIQUETA DE LA TOS





MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREVENCIÓN Y CONTROL IAAS

**ANEXO 6:
CUADRO RESUMEN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL POR ÁREAS**

Área	Equipo Protección Personal
Toma de muestra	• Guantes de procedimientos • Pechera
Procedimiento	• Guantes de procedimientos • Guantes estériles en procedimientos invasivos como por ejemplo instalación sonda Foley, toma cultivo y curaciones compleja según grado. • Mascarilla quirúrgica en procedimientos invasivos. • Protector Facial en procedimientos con irrigación • Pechera curaciones complejas con irrigación de suero fisiológico e instalación de sondas
Cirugía menor	• Guantes estériles • Delantal • Gorro
Dental	• Guantes de procedimientos • Guantes estériles en procedimientos invasivo cirugía odontológica • Mascarilla quirúrgica • Protector Facial en procedimientos con aerosol • Protector ocular (usuario) • Pechera en procedimientos con aerosol • Gorro
Matrona	• Guantes de procedimientos • Guantes estériles en procedimientos invasivos como inserción de DIU • Mascarilla quirúrgica en procedimientos invasivos •
Entrega de insumos	• Guantes de procedimiento • Guantes domésticos para retiro de material contaminado
Sala IRA- ERA	• Guantes de procedimiento • Mascarilla quirúrgica • Mascarilla KN95 o N95 en campaña de invierno • Protector Facial en kinesioterapia respiratoria • Pechera en kinesioterapia respiratoria
Podología	• Guantes de procedimiento • Mascarilla quirúrgica • Protector Facial • Pechera • Gorro
Aseo y desinfección	• Guantes domésticos • Mascarilla quirúrgica • Protector facial en aseo terminal • Pechera



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREVENCIÓN Y CONTROL IAAS

2 PRECAUCIONES ADICIONALES

Se basan en el mecanismo de transmisión de los microorganismos y se utilizan cuando las precauciones estándar no son suficientes para disminuir esta transmisión.

Su racionalidad se basa en interrumpir el mecanismo de transmisión del agente.

Son complementarias a las precauciones estándar y se aplican en pacientes seleccionados. Dependiendo del tipo de patología y su mecanismo de transmisión puede ser más de una precaución.

Tipos de Precauciones adicionales

Precauciones basadas en los mecanismos de transmisión que son.

- Respiratoria o vía aérea
- De gotitas
- De contacto.

2.1 Precaución Respiratoria o Aérea

Estas precauciones están orientadas a reducir riesgo de infecciones transmitidas por vía aérea.

Se aplica a aquellas patologías que se transmiten a partir de partículas de 5 micrones o menos, generadas por gotitas eliminadas por vía aérea y que pueden permanecer en el aire en suspensión por largos períodos de tiempo. Los microorganismos pueden ser dispersados por corrientes de aire.

Medidas de control por vía aérea:

- De ser posible evitar la entrada de personal susceptible al box de atención, en caso de sarampión y varicela, si esto no es posible, el personal susceptible debe usar mascarilla de alta eficiencia.
- Uso de mascarillas de alta eficiencia (N95), por el personal.
- Desinfección de equipos no críticos individuales (fonendoscopios, equipos de presión, termómetros).
- En caso de traslado, el paciente debe usar mascarilla.
- Sistema de extracción de aire exterior.

	Centro de Salud Familiar Villa Nonguén	Código: GCL 3.2
		Edición: 04
		Fecha Elab: Diciembre 2024
		Página 23 de 51
		Vigencia: Diciembre 2029
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREVENCIÓN Y CONTROL IAAS		

Indicaciones:

- Sospecha tuberculosis
- Sarampión
- Varicela (Se recomienda agregar precaución de contacto)
- Herpes zoster diseminado
- Influenza aviar

2.2 Precauciones por Gotitas

Orientadas a reducir riesgo de infecciones transmitidas por gotitas gruesas, definidas como partículas de diámetro de 5 micrones o más.

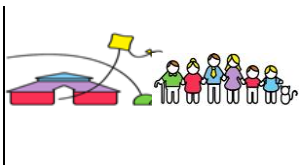
Disminuir el riesgo de infecciones producto de la exposición de la conjuntiva o mucosa nasal u oral a partir de partículas de 5 micrones y más, generadas por pacientes o portadores de agentes, a partir de tos, estornudos, al hablar o algunos procedimientos. Requiere contacto estrecho entre la fuente y el paciente susceptible, ya que las gotas permanecen poco tiempo en suspensión, puesto que, por su peso, estas gotitas decantan dentro del radio de un metro alrededor del paciente.

Medidas de control por gotitas:

- Uso de mascarilla en el radio de un metro del paciente.
- Uso de equipos no críticos desinfectados (fonendoscopios, equipos de presión, termómetros, etc.).
- En caso de traslado, el paciente debe usar mascarilla.

Indicaciones:

- Infecciones invasivas por H. influenzae y N. meningitidis, SAR
- Difteria e infecciones estreptocócicas del aparato respiratorio.
- Coqueluche.
- Infección respiratoria por Micoplasma, Neumonía atípica.
- Adenovirus y parvovirus B19.
- Influenza, Parotiditis
- Infecciones por virus hanta.
- Pacientes VRS y SARCOV (Se agrega precaución de contacto)



2.3 Precauciones por Contacto

Orientadas a reducir riesgo de infecciones transmitidas por contacto directo o indirecto entre un paciente y otro y entre el paciente y el personal.

Transferencia de piel a piel de agentes desde una persona infectada o colonizada a un paciente susceptible.

Transferencia a través de un objeto contaminado o por las manos no lavadas del personal.

Medidas de control por contacto

- Precauciones estándar, componente general
- Uso de guantes y delantal individual o pechera al atender al paciente
- Remoción de los guantes y pechera desechable (eliminarlo en basura)
- Uso de equipos exclusivos al usuario

Indicación por contacto:

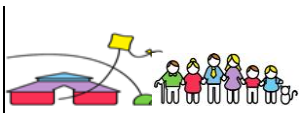
- Infección o colonización por bacterias multiresistentes de importancia epidemiológica, en este grupo se debe incluir a: *Staphylococcus Aureus*, *Acinetobacter Baumannii*, *Klebsiella*, *Pseudomonas*, *Enterococcus*, *Enterobacter*
- Infecciones entéricas por *C. Difficile*, *Escherichia Coli*, *Enterohemorrágico*, *Shigella*, *virus hepatitis*, *rotavirus*.
- Virus respiratorio sincicial, parainfluenza.
- Lesiones de piel altamente contagiosa S. herpes simple, impétigo, celulitis.
- Pacientes VRS y SARCOV (Se agrega precaución de gotitas)

2.4 Instalación y retiro de EPP (Anexo 1 y 2)

Las indicaciones de utilización de EPP serán de acuerdo con el contexto epidemiológico o ciertos casos de alto riesgo de infección

Instalación de EPP: Para la colocación de EPP limpio deberá:

1. Retirar joyas, relojes.
2. Realizar higiene de manos.
3. Colocar buzo y cerrar hasta el cuello si correspondiera.
4. Colocar mascarilla
5. Realizar higiene de manos.
6. Colocar pechera impermeable anudándola por detrás si correspondiera.
7. Colocar escudo facial limpio.
8. Colocar guantes de látex.



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREVENCIÓN Y CONTROL IAAS

Para el **retiro de EPP** usted deberá:

1. Retire la pechera. tome la pechera a la altura de la cintura desde la cara que mira hacia el exterior y traccíonela de forma firme y controlada hacia el frente hasta que se rompan los lazos y suéltelos libremente.
2. En conjunto con la pechera retire los guantes y deséchelos en el contenedor de residuos al igual que la pechera formando una pelota.
3. Eliminar pechera y guantes en contenedor según REAS.
4. Realizar higiene de manos.
5. Retirar escudo facial.
6. Retirar buzo.
7. Retirar mascarilla de alta eficiencia
8. Realizar higiene de manos.

ANEXOS:

- Anexo 1: Instalación de equipo de protección personal
- Anexo 2: Retiro de equipo de protección personal



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREVENCIÓN Y CONTROL IAAS

ANEXO 1:

INSTALACION EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL



1. Retirar joyas, relojes, pulseras y otros ítems personales, incluidos teléfonos celulares.



2. Realizar higiene de manos.



3. Colocar mascarilla y realizar prueba de control de sellado con la mascarilla o respirador tipo N95 o equivalente.



4. Realizar higiene de manos.



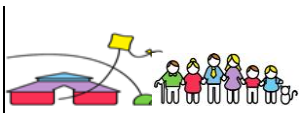
5. Colocar pechera impermeable y desechable anudándola por la cintura.



6. Colocar protección ocular: escudo facial.



7. Colocar guantes.



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREVENCIÓN Y CONTROL IAAS

ANEXO 2:

RETIRO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL



1. Tome la pechera a la altura de la cintura desde la cara que mira hacia el exterior y tracciónela de forma firme y controlada hacia el frente hasta que se rompan los lazos y suéltelos libremente.
2. En conjunto con la pechera retire los guantes y deséchelos en el contenedor de residuos al igual que la pechera formando una pelota y elimínelo.



3. Realice higiene de manos.



4. Tome antiparras o escudo facial, con una mano tomar la fijación del escudo en la región posterior de la cabeza y traccionar, alejándola hacia atrás, durante el retiro de las antiparras mantenga sus ojos cerrados.



5. Realice higiene de manos.



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREVENCIÓN Y CONTROL IAAS

3 TÉCNICA ASEPTICA

INTRODUCCION

Las IAAS son un conjunto de distintas patologías con factores de riesgo diferentes. Existen factores que contribuyen a aumentar el riesgo de que se presente una IAAS, una de ellas son las técnicas invasivas curativamente favorable, pero que rompen las barreras de protección natural del organismo dejando una puerta de entrada a los microorganismos: por otra parte el incremento de procedimientos invasivos genera mayor contacto del personal del salud con el usuario y con los equipos que se utilizan existiendo un riesgo potencial de infección en los funcionarios, a partir de este contacto.

Una de las medidas globales entre la prevención de la mayoría de las IAAS es la Técnica Aséptica en la realización de procedimientos invasivos.

OBJETIVO

- Prevenir y controlar Infecciones exógenas y endógenas durante los procedimientos invasivos tales como: Cirugía menor, inserción implanon, extracción dental.

RESPONSABILIDAD

RESPONSABLE	ACTIVIDAD
Funcionarios con atención clínica directa	• Cumplir la norma
Encargados de áreas Dental, Procedimientos, Matrona.	• Hacer cumplir la norma
Encargado de IAAS	• Supervisar el cumplimiento de las normas.



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREVENCIÓN Y CONTROL IAAS

DEFINICIONES

- **Procedimientos Invasivos:** Cualquier acción de la atención clínica que altera las barreras naturales del organismo o del medio interno del paciente o que trastoque microorganismos de un lado a otro que no son saprofitos.
- **Técnica aséptica:** Es el conjunto de procedimientos y actividades que realiza el personal de salud, conducentes a disminuir al mínimo la contaminación microbiana durante la atención de los pacientes
- **Antisepsia:** Acciones o técnicas cuyo objetivo es crear situaciones adversas que impidan el desarrollo de microorganismos, incluso pueda destruirlos.
- **Asepsia.** Conductas y prácticas utilizadas para impedir el acceso de microorganismos (contaminación) al campo de trabajo.
- **Procedimientos de la técnica aséptica:**
 1. Lavado quirúrgico de manos
 2. Uso de guantes estériles
 3. Preparación de la piel
 4. Campo estéril
 5. Material y equipos estériles
 6. Mascarilla
 7. Bata estéril

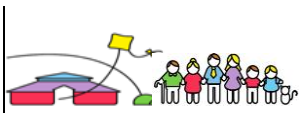
3.1 LAVADO QUIRURGICO DE MANOS

Objetivo:

- Disminuir la concentración de bacterias de la **flora residente**.
- Remover completamente la **flora transitoria** adquirida por contacto reciente con pacientes, objetos contaminados o sus superficies.

Indicaciones:

- Cirugía menor médica
- Cirugía odontológica
- Inserción de implante



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREVENCIÓN Y CONTROL IAAS

Procedimiento: (Anexo1)

- Use uñas cortas, limpias y sin esmalte.
- Retire reloj y alhajas. Descúbrase los brazos hasta más arriba de los codos.
- Ubíquese en posición cómoda frente al lavamanos, abra la llave del agua a temperatura aceptable hasta finalizar el procedimiento. El agua debe estar tibia.
- Moje las manos y antebrazos hasta el codo con agua antes de usar jabón con antiséptico aplicando una dosis de la solución.
- Junte las manos y frótelas haciendo movimientos de rotación, continúe con las muñecas.
- Entrelace los dedos para frotar los espacios interdigitales, haciendo movimientos hacia arriba y hacia abajo. Mantenga las manos sobre el nivel de los codos.
- Limpie las uñas si fuera necesario, use un dispositivo para limpiarlas.
- Enjuague las manos bajo el chorro de agua, dejando escurrir esta desde la punta de los dedos hasta los codos, una mano primero y luego la otra.
- Cierre las llaves si son de pedal o coderas. En caso contrario debe cerrarlo otra persona.
- Secar las manos con compresas estériles, desde los dedos hacia los codos y eliminar en depósito indicado.
- Tiempo de lavado clínico 3 minutos.

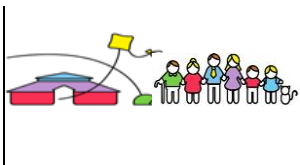
3.2 USO DE GUANTES ESTERILES

Objetivo.

El uso de guantes estériles tiene como objetivo disminuir la transmisión de microorganismos de las manos, del personal al paciente durante los procedimientos invasivos que necesitan de técnica estéril, por lo tanto, la correcta colocación y manipulación aseguran la técnica aséptica y la calidad de atención del paciente.

Indicaciones:

- Cirugía menor médica y odontológica
- Quemaduras
- Curaciones grado 3 y 4 a excepción de úlceras varicosas
- Curaciones pie diabético grado 2-3-4
- Instalación Sonda Foley.



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREVENCIÓN Y CONTROL IAAS

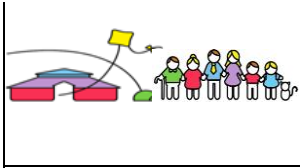
- Toma de cultivos.
- Inserción de DIU e implanon.

Consideraciones:

- Si en el proceso del colocado de guantes estos quedan mal puestos, deben ser ajustados una vez que ambas manos estén enguantadas.
- Recuerde que ahora sus manos con guantes se encuentran estériles por lo tanto usted no debe tocar ningún objeto que no se encuentre estéril"

Procedimiento de colocación de guantes estériles: (Anexo 2)

- Lavarse las manos según norma
- Tomar el paquete de guantes
- Verificar indemnidad del envoltorio, correcto viraje del control químico externo y observe fecha de vencimiento. Recuerde que cualquier alteración significa que usted no puede usar esos guantes ya que estos no se encuentran estériles.
- Abrir el paquete de guantes por donde se indica en el envoltorio
- Sacar el sobre con los guantes y colóquelo sobre un lugar plano, limpio seco y seguro. Diríjase a la línea media en la parte inferior y proceda a tomar los bordes y abrirlos hacia el exterior con la precaución de no tocar los guantes que se encuentran en el interior.
- Abrir el primer doblez.
- Dejar bien extendido el papel donde vienen los guantes, tomando el papel solo desde el borde.
- Observar que los guantes están rotulados de la siguiente manera:
 - “**R**” que significa Right para el guante que irá en la mano derecha
 - “**L**” que significa Left para el guante que irá en la mano izquierda
- Hacer pinza con el dedo índice y pulgar de la mano dominante tome el guante por la base, introduciendo aproximadamente 1 cm. el dedo pulgar dentro del guante, levántelo alejado del cuerpo y de objetos que pudiesen ponerse en contacto con ellos e introduzca la mano en forma de pala con el dedo pulgar sobre la palma mirando hacia arriba y ajuste el guante a su mano.
- Con la mano (que tiene el guante puesto) en forma de pala, introducir en el doblez del guante con los dedos mirando hacia usted.
- Colocar su mano derecha en forma de pala mirando hacia arriba e introducir el guante en su mano. Ajustar calzando los dedos de su mano con el guante.



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREVENCIÓN Y CONTROL IAAS

Procedimiento Retiro de guantes estériles (Anexo 3)

- Para retirar el primer guante, tome el borde por la cara externa dé vuelta completamente el guante.
- Para retirar el segundo guante, tómelo del puño dé vuelta completamente el guante y deseche según norma.
- Realice higienización de manos.

3.3 PREPARACION DE LA PIEL

La preparación de la piel depende del objetivo que se desea alcanzar en relación con la flora microbiana de la piel del usuario, seleccionando el producto de acuerdo a la flora que se desea eliminar y al riesgo que conlleva el procedimiento que se va a realizar. Antes de utilizar un antiséptico la piel debe estar libre de suciedad visible.

Preparación piel zona operatoria:

- Mantener vello en su sitio, si es muy abundante solo recortarlo.
- Realizar lavado por arrastre con un jabón antiséptico de efecto residual.
- Retirar excedente de jabón.
- Aplicar un antiséptico de la misma naturaleza que el jabón de manera circular y de adentro hacia afuera.
- Esperar tiempo de acción de 3 minutos antes de realizar la incisión.

Antisépticos recomendados en cirugía menor:

- Povidona Yodada 10% solución (cirugía menor de 2 horas)
- Clorhexidina 2% solución acuosa (en alergia al Yodo, cirugía mayor de 2 horas)

Lavado de manos quirúrgico.

- Clorhexidina 2% Jabón líquido

Preparación de la piel instalación catéteres vasculares periféricos:

- En piel libre de suciedad visible uso de alcohol 70°



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREVENCIÓN Y CONTROL IAAS

3.4 CAMPOS ESTERILES

Objetivo:

Disponer de un área de trabajo aséptico para la realización de un procedimiento invasivo o intervención quirúrgica.

Consideraciones

- Superficie de tela o material impermeable, esto se logra con tramas de tejido de 0.3 micrones o telas no tejidas.
- Deben cubrir más allá del campo de acción actuando como una barrera entre las cavidades estériles cuya barrera está alterada y el medio contaminado.
- Mantenerse secas ya que, al mojarse, las bacterias de las aéreas no estériles llegan al campo estéril.

Caso a utilizar.

- Extracción dental (capucha dental, paños clínicos, paños perforados)
- Inserción implanon (pañes perforados)

3.5 VESTUARIO ESTÉRIL

Objetivo:

Reducir la posibilidad de contaminación entre el operador y el campo quirúrgico o procedimiento invasivo

Consideraciones:

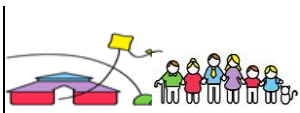
- Deben mantenerse secas, a fin de evitar la contaminación.
- Deben evitar el traspaso de microorganismos
- Deben ser largas y amplias que faciliten los movimientos
- Mangas largas y con puños.

Caso a utilizar:

- Cirugía menor (Kit de ropa cirugía menor)

ANEXOS:

- Anexo 1: Técnica lavado quirúrgico
- Anexo 2: Colocación de guantes estériles
- Anexo 3: Retiro de guantes estériles

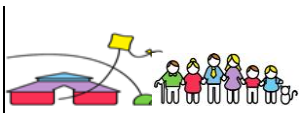


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREVENCIÓN Y CONTROL IAAS

ANEXO 1:

TECNICA LAVADO QUIRURGICO DE MANOS



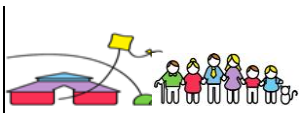


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREVENCIÓN Y CONTROL IAAS

ANEXO 2:

COLOCACION DE GUANTES ESTERILES



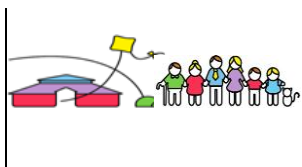


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREVENCIÓN Y CONTROL IAAS

ANEXO 3:

RETIRO DE GUANTES ESTERILES





MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREVENCIÓN Y CONTROL IAAS

4 ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES

INTRODUCCIÓN

La existencia de microorganismos en personas y superficies inanimados nos insta a llevar a cabo acciones que permitan detener o minimizar su desarrollo con la aplicación de sustancias químicas para realizar procedimientos clínicos seguros para el usuario.

Los antisépticos deben utilizarse para la reducción de la colonización en pacientes, previo a las acciones de atención clínica que lo requieran.

Los desinfectantes en tanto, deben ser utilizados en las superficies y objetos inanimados que participan directa o indirectamente en el proceso asistencial.

Cabe destacar que en ambos casos siempre es necesaria una etapa previa de lavado con agua y solución jabonosa a fin de evitar la inactivación de los agentes activos por contacto con residuos orgánicos.

Es importante considerar que las diferentes formas de vida microbiana tienen una resistencia diferente frente a antisépticos y desinfectantes, lo que debemos considerar en la elección de ellos de acuerdo al objetivo deseado.

OBJETIVO

- Lograr el uso racional de antiséptico y desinfectantes en CESFAM, de acuerdo a su capacidad germicida, disponibilidad económica y seguridad para pacientes y personal.

RESPONSABILIDAD

RESPONSABLE	ACTIVIDAD
Comité de Farmacia	• Seleccionar y gestionar la compra de los desinfectantes y antisépticos más adecuados de acuerdo a las necesidades de las unidades.
Encargado de unidades	• Supervisar el uso y conservación de los productos en las unidades a su cargo • Determinar las cantidades necesarias de acuerdo a los procedimientos que se realicen.
Funcionarios de unidades	• Conocer las propiedades de los antisépticos y desinfectantes • Procurar su uso racional
Encargada IAAS	• Supervisar el cumplimiento.

	Centro de Salud Familiar Villa Nonguén	Código: GCL 3.2
		Edición: 04
		Fecha Elab: Diciembre 2024
		Página 38 de 51
		Vigencia: Diciembre 2029
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREVENCIÓN Y CONTROL IAAS		

DEFINICIONES

- **Antisépticos:** Agentes germicidas usados sobre la piel y otros tejidos vivos para disminuir el inóculo de microorganismos. Estos se encuentran normados según Anexo 1.
- **Desinfectantes:** Se definen como germicidas, que pueden ser utilizados en las superficies ambientales y de los artículos médicos. Se usan para la eliminación de microorganismos patógenos, con excepción de las esporas. Estos se encuentran normados según Anexo 2
- **Limpieza:** Es la eliminación, por acciones mecánicas con o sin uso de detergente de la materia orgánica y suciedad.
- **Desinfección:** Significa destrucción de todas las formas de vida de los patógenos que se encuentran en objetos inanimados, pero no elimina esporas bacterianas.

4.1 Generalidades

- A mayor nivel de contaminación, mayor es el tiempo necesario para actuar del agente químico.
- La presencia de sangre, pus, mucus o heces en el material a desinfectar, impiden el contacto directo con los compuestos activos, inactivándolos.
- Siempre deben respetarse las concentraciones indicadas por el fabricante y no deben mezclarse.
- Los objetos con lúmenes y articulaciones dificultan la acción de los agentes.
- Todos estos productos son de uso externo, no deben ser aplicados en mucosas, ni cavidades a excepción de la clorhexidina.
- El alcohol debe ser aplicado en el momento de su uso, la preparación de tómulas con alcohol por más de dos minutos antes del procedimiento, no tendrá ningún efecto desinfectante.
- No se deberá rellenar frascos de antisépticos ni desinfectantes.
- Deben mantenerse siempre tapados herméticamente, en lugares secos, alejados de fuentes de calor, según indicaciones del fabricante.
- Una vez abierto, los envases de antisépticos tendrán una vigencia de 30 días a excepción de los indicados en la tabla. La fecha de apertura debe registrarse en forma visible en el envase sobre papel y no directamente en el envase para evitar contaminación.



4.2 Procedimiento aplicación de Antisépticos

- Si existe suciedad visible limpie con agua y jabón la zona a desinfectar
- Aplique antiséptico con tórula o gasa de adentro hacia afuera de manera circular por una sola vez y elimine.
- Deje actuar según inicio de acción.
- Realice el procedimiento.

4.3 Procedimiento aplicación de Desinfectantes

- Si existe suciedad visible limpie con agua y jabón la zona a desinfectar.
- Utilizar equipo de protección personal y diluir según Anexo 3
- Aplique desinfectante en superficies, y piso de forma de barrido o zig – zag, desde la zona limpia a la sucia.
- Deje actuar según inicio de acción.

ANEXOS:

- Anexo 1: Indicaciones de uso de antisépticos
- Anexo 2: Indicaciones de uso de desinfectantes
- Anexo 3: Desinfectantes y dilución



Centro de Salud Familiar Villa Nonguén

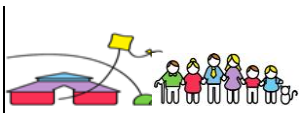
Código: GCL 3.2
Edición: 04
Fecha Elab: Diciembre 2024
Página 40 de 51
Vigencia: Diciembre 2029

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREVENCIÓN Y CONTROL IAAS

ANEXO 1

INDICACIONES USO DE ANTISÉPTICOS

ANTISÉPTICO	USO	Duración una vez abierto
Clorhexidina	Jabón: Lavado de manos quirúrgico en cirugías menores y odontológicas. Atención Podología.	Según fecha de vencimiento
	Antiséptico: Pincelación de la piel.	1 mes
	Colutorio: Profilaxis dental.	6 meses
Povidona yodada 10%	Pincelación de la piel indemne.	1 mes
Alcohol 70°	Desinfección de la piel previo a procedimientos invasivos.	1 mes
Isopropyl Alcohol 70°	Desinfección de piel previo a procedimientos.	30 segundos
Alcohol gel	Higienización de manos en atención clínica.	Según fecha de vencimiento
Agua oxigenada 1vol	Preparación previa a lavado de oídos Irrigación de conductos dentales infectados o necrosados.	1 mes
Hipoclorito de Sodio al 3%	Irrigación de conductos dentales infectados o necrosados.	3 meses



Centro de Salud Familiar Villa Nonguén

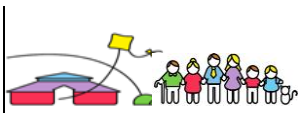
Código: GCL 3.2
Edición: 04
Fecha Elab: Diciembre 2024
Página 41 de 51
Vigencia: Diciembre 2029

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREVENCIÓN Y CONTROL IAAS

ANEXO 2:

INDICACIONES USO DE DESINFECTANTES

DESINFECTANTES	USO	Duración una vez abierto
Cloro 0.1%	Desinfección de superficies, paredes, pisos, muebles.	Diluido 24 hrs.
Cloro 0.5%	Desinfección de superficies en derrames.	Diluido 24 hrs.
Alcohol 70°	Desinfección de ampollas y superficies pequeñas.	1 mes
Isopropyl Alcohol 70°	Desinfección de artículos pequeños, termómetros, campana fonendoscopio.	30 segundos
Amonios cuaternarios	Limpieza de superficies, muros, pisos y muebles. (detergente).	Diluido 15 días Toallas de 1 solo uso
Alcohol Isopropyl - gluconato de clorhexidina	Desinfección de transductor ecógrafo y ultrasonido.	6 meses
Cloruro de amonio cuaternario	Desinfección de fresas dentales.	1 mes



Centro de Salud Familiar Villa Nonguén

Código: GCL 3.2

Edición: 04

Fecha Elab: Diciembre 2024

Página 42 de 51

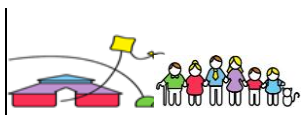
Vigencia: Diciembre 2029

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREVENCIÓN Y CONTROL IAAS

ANEXO 3:

DESINFECTANTES Y SU DILUCIÓN

DESINFECTANTE	DILUCIÓN	DURACIÓN	USO	PRECAUCIONES
AMONIO CUATERNARIO (Germekil).	Dilución de 1:50 10cc de solución en 0.5lt. de agua 20cc de solución en 1 litro de agua 30cc de solución en 1.5 litros de agua. 40cc de solución en 2 litros de agua 50cc de solución en 2,5 litros de agua	15 días	+ Box Semi-críticos para pisos y superficies (Aseo Concurrente) + Box Críticos: Para limpieza previa a desinfección terminal y en aseo concurrente pisos y superficies	Peligrosa su ingestión, causa quemaduras. No inhalar En caso de contacto con los ojos o con la piel lave inmediatamente con agua fría y consulte médico. Peligrosa su ingestión, causa quemaduras. No inhalar En caso de contacto con los ojos o con la piel lave inmediatamente con agua fría y consulte médico.
AMONIO CUATERNARIO (Forward DC)	Dilución de 1:10 50cc de solución en 0.5lt de agua 100cc de solución en 1 litro de agua 150cc de solución en 1.5 litros de agua. 200cc de solución en 2 litros de agua 250cc de solución en 2,5 litros de agua	15 días	+ Limpieza exclusivo para baños y manitorio.	
PANOS DE AMONIO CUATERNARIO	No aplica	1 mes una vez abierto	+Limpieza de escritorios +Limpieza de teclados	
CLORO EN POLVO Cloro 0.1%	1 sobre por 2.5 litros de agua fría	1 día	+ Aseo concurrente de Box Críticos en pisos y superficies	Peligrosa su ingestión, causa quemaduras. No inhalar En caso de contacto con los ojos o con la piel lave inmediatamente con agua fría y consulte médico. No mezclar con otros desinfectantes ni detergentes ácidos ni amoniacales.
CLORO EN POLVO Cloro 0.5%	1 sobre por 1 litro de agua fría	1 día	+ En caso de presencia de fluidos corporales + Aseo terminal (pisos, paredes y superficies)	No usar en superficies metálicas porque se deterioran. Mezclar solo con agua. Para su manipulación use protección. Guantes de látex, delantal y antiparras.
Detergente enzimático	10cc de solución en 1 litro de agua tibia 5cc de solución en 500cc de agua 2.5cc de solución en 250cc de agua 1.5cc de solución en 150cc de agua 0.5cc de solución en 50cc de agua	Una vez finalizado el procedimiento se debe eliminar	-Limpieza de camisas toma de muestra	
Isopropyl+ Gluconato de Clorhexidina (Betchol)	Sin dilución	1 mes	Desinfección de fresas	Dejar sumergido completamente el material. Aplicar con guantes Pasada la hora se encuentra desinfectados
Alcohol 70°	Sin dilución	1 mes una vez abierto	Desinfección ampollas y superficies pequeñas, refrigeradores	Agente volátil
Isopropyl Alcohol 70°	Sin dilución	30 segundos	Desinfección de artículos pequeños, termómetros, campana fonendoscopio	Agente volátil



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREVENCIÓN Y CONTROL IAAS

5 MEDIDAS DE PREVENCIÓN IAAS

5.1 PREVENCIÓN DE INFECCIÓN DE HERIDA OPERATORIA

5.1.1 Preparación preoperatoria de la piel

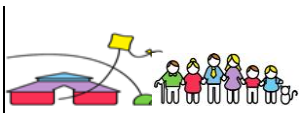
- Su objetivo es eliminar flora microbiana transitoria de la piel por arrastre mecánico con el fin de prevenir infección de herida operatoria.
- La preparación de la piel de la zona operatoria del paciente en box se realizará dentro de media hora antes previas a la cirugía.
- Dicha preparación incluye lavado con agua y jabón de área operatoria en círculos concéntricos y centrífugos y de ser necesario, recorte de vello
- No rasurar el sitio quirúrgico por presentar riesgos de microcortes que se colonizan rápidamente.
- La piel quemada o traumatizada debe ser preparada con irrigación salina normal. La piel sana y las mucosas pueden ser preparadas usando antisépticos.
- La piel debe estar limpia antes de la colocación de un antiséptico y por lo tanto se debe realizar un baño previo a la cirugía.
- El área alrededor del sitio de incisión debe ser limpiada para remover suciedad y grasitud antes de realizar la preparación con un antiséptico.

5.1.2 Preparación de piel con antiséptico

- Realizar lavado de área quirúrgica con agua y jabón antiséptico en círculos concéntricos y centrífugos, cubriendo un área suficiente para incluir posibles ampliaciones de la incisión o colocación de drenajes.
- Utilizar el antiséptico normado por el centro de salud.
- Pincelar la zona operatoria con técnica aséptica con solución antiséptica posterior al lavado de dicha área, teniendo precaución que el antiséptico utilizado contenga el mismo principio activo del jabón antiséptico utilizado previamente.
- Pincelar desde lo más limpio a lo más sucio, sin repasar.

5.1.3 Interrupción de m.o. persona a persona Higiene de manos

- Realizar técnica de lavado quirúrgico de manos.
- Lavado quirúrgico de manos por todo funcionario que tome contacto con el campo quirúrgico o material estéril.
- Higiene de manos de todo funcionario que ingrese a sala de procedimiento.



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREVENCIÓN Y CONTROL IAAS

5.1.4 Limpieza y desinfección de sala de procedimientos

- Realizar limpieza y desinfección en zonas visiblemente sucias o contaminadas antes de realizar el siguiente procedimiento.
- Al final de la jornada realizar aseo terminal de sala de procedimiento; lavar con solución jabonosa, enjuagar con agua y desinfectar con solución de cloro al 0.1%.
- No realizar limpieza especial después de cirugías sucias o contaminadas.
- Disponer ropa y materiales utilizados en dispositivos cerrados, lavables o desechables.
- Las lámparas deben ser con cubiertas lisas que no acumulen polvo.
- Pisos, muros y techos deben ser lisos y resistentes a los procedimientos frecuentes de limpieza y desinfección.
- Equipos, máquinas y muebles deben ser revestidos por superficies lavables que faciliten limpieza y desinfección frecuente.

5.1.5 Asepsia

- Todo el material quirúrgico debe ser estéril.
- Los antisépticos a utilizar deben ser los incluidos en la norma vigente del establecimiento.
- Se utilizará solo material estéril con control virado, con fecha vigente y con envase indemne.
- Todo instrumental con suciedad visible y con deterioro de oxidación, agrietado y con salpicaduras, no deben ser utilizados.
- La mesa de instrumental quirúrgico debe ser preparada lo, mas cercano al inicio de la cirugía.
- Los campos quirúrgicos deben ser dispuestos en áreas limpias y secas, así como también los paquetes de ropa estéril.
- Materiales que caen bajo el nivel de la cintura deben ser considerado como material contaminado y cambiarlo.
- Zona operatoria debe ser separada durante toda la cirugía.

5.1.6 Prevención de contaminación de herida operatoria

- Finalizada la cirugía debe cubrirse la herida con apósito estéril con el objetivo de absorber fluidos, evitar contaminación y proteger de agresiones externas.
- Evitar descubrir o manipular la herida durante las primeras 24 a 48 horas.
- Controlar la glicemia en pacientes diabéticos (bajo 200mg/dl) previo y post cirugía.



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREVENCIÓN Y CONTROL IAAS

- Drenajes deben mantener circuito cerrado y realizar la curación del sitio de inserción con técnica aséptica

5.2 RECOMENDACIONES PREVENCIÓN DE ISO/ISQ

Preparación paciente.

- Identificar y tratar infecciones remotas y posponer la cirugía hasta que las infecciones estén resueltas.
- No realizar remoción de vellos alrededor del sitio operatorio, a menos que interfiera con la cirugía.
- Control de glicemia en pacientes diabéticos y evitar hiperglicemia peri-operatoria.
- Lavar y preparar la piel.
- Uso de un apropiado antiséptico para preparar la piel.
- Mantener uñas cortas y no usar uñas artificiales.
- Lavado quirúrgico de manos (manos y codos)
- Mantener las manos en alto y lejos de los codos flexionados.
- Secarse manos con paño estéril y colocarse delantal y guantes estériles
- Mantener puerta cerrada.
- Disminuir a mínimo la circulación dentro de la sala de procedimientos.
- Mascarilla quirúrgica debe cubrir completamente boca nariz.
- Usar gorro.
- Notificar **TODAS** las infecciones de herida operatoria pesquisadas en su centro de salud. Enviarlas vía correo al hospital donde se realizó la cirugía.

5.3 PREVENCIÓN DE INFECCIONES ASOCIADAS A PROCEDIMIENTOS INVASIVOS

5.3.1 CATETER VASCULAR

Complicaciones más frecuentes asociadas al uso de catéter vascular

- a) Infecciones (locales - sistémicas)
- b) Hematomas
- c) Flebitis - Tromboflebitis - Endocarditis
- d) Embolias
- e) Extravasaciones o infiltraciones.
- f) Desplazamiento del catéter



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREVENCIÓN Y CONTROL IAAS

Tipos de catéteres

- Agujas.
- Mariposas.
- Catéter Venoso Periférico.
- Catéter Venoso Central.

Complicaciones asociadas a catéteres vasculares:

1. Extravasaciones que pueden ser causadas por:

- Perforación del vaso.
- Retiro incompleto o desplazamiento (durante la administración de fluidos).

Cómo evitar extravasaciones:

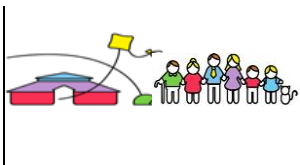
- Elegir un catéter de lumen adecuado al vaso
- Elegir zona adecuada de punción.
- Canalizar y fijar bien el catéter.
- Observarlo constantemente.
- Educar al paciente para contar con su colaboración
- Si hay extravasación suspender el flujo, retirar el catéter, presionar, registrar y avisar.

2. Obstrucción del catéter

- Acodamiento o mala posición del catéter.
- Precipitación de fármacos
- Término inadvertido de solución parenteral

Cómo evitar obstrucción

- Verificar posición del catéter.
- Paso permanente de fluidos.
- Lavar con suero fisiológico el catéter post-administración de fármacos o extracción de sangre.
- Diluir cuidadosamente los fármacos previa administración por el catéter.
- Si se obstruye: No haga presión, Aspire con una jeringa, Si no cede retire el catéter e inserte uno nuevo, pues podría provocar embolia, rotura del catéter, o desprendimiento de trombos.



3. Dolor asociado a la punción:

- Temor, vasoconstricción, mayor dificultad punción
- Escasez de recursos apropiados.
- Poca destreza del operador.

Cómo evitar el dolor

- Tranquilizar al paciente, explicándole el procedimiento
- Localizar un vaso posible de puncionar
- Elegir aguja o catéter en relación al calibre de vaso a puncionar.
- Realizar la técnica lo más atraumática posible

4. Flebitis causada por

- Inserción traumática
- Catéter de diámetro grande para el calibre del vaso puncionado.
- Velocidad alta del flujo administrado.
- Escasa dilución de fármacos. pH bajo o alta osmolaridad del líquido administrado.
- Falla en la técnica aséptica. (Reacción a pirógeno)
- Experiencia del operador.
- Duración del catéter vascular.
- Frecuencia del cambio de apósito.
- Infección relacionada con el catéter.
- Preparación de la piel.
- Condición del huésped.

5. Medidas de prevención de infecciones asociadas a catéter vascular periférico

- Previa indicación médica, el profesional que instala la vía venosa periférica debe realizar lavado clínico de manos o higiene de manos con alcohol gel antes y después de colocar o remplazar una vía venosa periférica; palpar o revisar.
- Realizar procedimiento con técnica aséptica, antiséptico a utilizar alcohol de 70 o isopropilo.
- El material que se utilice en la instalación de la vía venosa periférica debe ser de un solo uso y estéril, manteniendo su condición de esterilidad durante todo el procedimiento.
- Todas las punciones deben realizarse con guantes de procedimiento cuyo objetivo es



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREVENCIÓN Y CONTROL IAAS

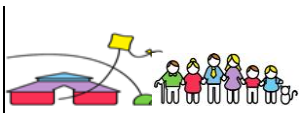
proteger al operador frente a un accidente cortopunzante o contaminación con fluido de alto riesgo.

- El sitio de punción debe cubrirse con apósito estéril y rotular fecha y hora de la instalación y el responsable.
- Se debe elegir el catéter de menor calibre que cumpla el objetivo de punción para la instalación de la vía venosa periférica.

5.3.2 CATETER URINARIO PERMANENTE

Medidas de Prevención de infecciones asociadas a catéter urinario permanente

- El procedimiento debe ser indicado por médico y debe realizarse con ayudante y técnica aséptica.
- Todo el material utilizado debe ser estéril y desechable.
- Realizar aseo genital según procedimiento descrito en protocolo de instalación catéter urinario permanente.
- El cuff o balón debe inflarse sólo con agua destilada estéril y no con suero fisiológico ya que este puede precipitar y obstaculizar su extracción posterior.
- Se debe realizar fijación externa para evitar desplazamientos.
- Se debe mantener siempre en circuito cerrado y permeable el sistema catéter/recolector.
- Se debe educar a usuario en:
 - La bolsa colectora debe mantenerse bajo el nivel de la vejiga y no tocar el suelo. Permite el drenaje por la fuerza de gravedad
 - La bolsa colectora debe vaciarse a intervalos regulares para evitar contacto entre orina del tubo de drenaje y la acumulada en la bolsa.
 - Rotar la fijación cada 24 horas para evitar maceraciones y úlceras por presión, puede realizarse junto con el aseo genital externo.
 - No se debe usar apósitos ni gasas húmedas en la zona de inserción del catéter, pueden constituir focos de infección.
 - Vaciar contenido de la bolsa recolectora cuando el contenido esté a $\frac{3}{4}$ de su capacidad, para evitar tracción y reflujo de la orina.



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREVENCIÓN Y CONTROL IAAS

- **NO** desconectar el recolector de la sonda
- **NO** colgar sonda en cinturones
- **NO** elevar bolsa por sobre la cintura
- **NO** doblar o acodar la sonda
- **NO** dejar la bolsa recolectora en el suelo
- **NO** dejar la llave de la bolsa recolectora abierta



	Centro de Salud Familiar Villa Nonguén	Código: GCL 3.2
		Edición: 04
		Fecha Elab: Diciembre 2024
		Página 50 de 51
		Vigencia: Diciembre 2029
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREVENCIÓN Y CONTROL IAAS		

6. BIBLIOGRAFIA

- Programa de control de infecciones asociada a la Atención en Salud, MINSAL 2019
- Ministerio de salud de Chile. Norma precauciones estándar. Extraído el 05 de octubre de 2013. Disponible en:
<http://www.minsal.cl/portal/url/item/d8615b8fdab6c48fe04001016401183d.pdf>
- Ministerio de salud de Chile. Normas de aislamientos y manual de procedimientos. Extraído el 03 de octubre de 2013. Disponible en:
<http://www.minsal.cl/portal/url/item/87957ff07b7cb1bee04001011f0135da>
- Resolución Exenta N° 550: Modifica norma general Técnica N° 199 sobre Esterilización y Desinfección en Establecimientos de Atención en Salud, aprobada por Resolución Exenta N° 380 del 2018, del Ministerio de Salud.
- Circular 37 N° 4, Actualización de las medidas de prevención y control de infecciones asociadas a la atención de salud en pacientes SARS COV 2, Subsecretaria de redes asistenciales Abril 2020.
- Antisépticos y desinfectantes apuntando al uso racional, Recomendaciones del Comité consultivo de IAAS, Sociedad Chilena de infectología, 2017
- Norma técnica N° 225 sobre programas de prevención y control de las infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS). Núm. 60 exento. - 26 de agosto de 2022.



Centro de Salud Familiar Villa Nonguén

Código: GCL 3.2

Edición: 04

Fecha Elab: Diciembre 2024

Página 51 de 51

Vigencia: Diciembre 2029

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREVENCIÓN Y CONTROL IAAS

7 HISTORIAL DE REVISIONES:

FECHA	EDICIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
Junio 2018	02	• Actualización de antisépticos y desinfectantes. • Actualización de técnica higiene de manos y se incorpora oportunidad en higiene de manos. • Se retira indicadores. • Se retira capítulo de saneamiento ambiental y epidemiología
Junio 2021	03	• Separación de manual de IAAS con entrega y recepción de insumos • Se actualiza conceptos de aislamientos en precauciones adicionales y se incorpora SARCOV como precaución de gotitas y de contacto. • Se agrega instalación y retiro de EPP.
Diciembre 2024	04	• Se realiza modificaciones de Anexos de precauciones Estándar. • Se realiza modificación en anexos antisépticos y desinfectante.